

**Université Constantine 3. Faculté de médecine. Département de médecine
Annexe Faculté de médecine Batna**

Abord et examen clinique d'un patient 2ème partie

**Dr Kerouaz Nasser
Médecine interne**

**Selon le programme national d'Enseignement de 3ème année médecine.
Année universitaire 2025/2026**

Objectifs du cours:

- ✓ Comprendre le déroulement d'un examen clinique:
- ✓ Identifier les quatre temps essentiels de l'examen physique:
Inspection, palpation, percussion, auscultation.
- ✓ Distinguer un examen clinique normal d'un examen clinique pathologique.
- ✓ Initiation aux gestes pratiques simples.

Plan du cours:

I. Règles générales

- **Préparation à l'examen clinique**
- **Matériel pour l'examen physique**

II. Les techniques de base de l'examen physique

- **Inspection**
- **Palpation**
- **Percussion**
- **Auscultation**

III. Séquence de l'examen physique

I. Règles générales

1. Préparation

Mettre le patient en **confiance**

Installer le Patient **confortablement**

Patient **déshabillé, allongé**

Le respect de **son intimité et sa pudeur** : drap blanc

Le respect de la **confidentialité**

Salle **bien éclairée**, chauffée / climatisée

Un environnement **silencieux**

La disponibilité du médecin

Lavage des mains, avant et après l'examen

L'examineur se **tient à droite du patient** et utilise sa main droite pour la plus part des manœuvres.

2. Matériel pour l'examen clinique

- Blouse blanche

- Matériel nécessaire:

Stéthoscope : Auscultation

Appareil de mesure de la pression artérielle

Marteau à reflexe: Tester les reflexes ostéo-tendineux

Diapason 128 Hz: Tester la sensibilité vibratoire (pallesthésie)

Mètre ruban, abaisse langue, lampe de poche

Thermomètre: Mesure de la température corporelle

Montre marquant les secondes: Mesure de la fréquence cardiaque et respiratoire

Pèse personne, toise: poids/ taille et calcul du BMI

Bandelettes : Analyse d'urine

Gant et lubrifiant: Toucher rectal

Coton, tubes à essais, épingles à nourrices : Tester la sensibilité superficielle

Oto-ophtalmoscope si possible

Stylo, papier.

II. Les techniques de base de l'examen

Notez que l'examen physique pour chaque système ou organe repose sur 4 techniques classiques:

1. **Inspection**
2. **Palpation**
3. **Percussion**
4. **Auscultation**

1. Inspection : très riche en information

L'examineur doit s'entraîner à observer, " apprendre à l'œil à voir".

Observation minutieuse de l'aspect général du patient, son état de conscience, sa posture, sa démarche, son comportement, son humeur, sa mimique, sa peau, son état nutritionnel, les mouvements oculaires, la symétrie de son thorax, les contours de l'abdomen, présence d'un œdème des membres inférieurs, d'un hippocratisme digital, d'un phénomène de Raynaud, d'une érythrose palmaire.

Bien connaître certaines attitudes:

L'asymétrie du visage en cas de paralysie faciale

La marche en fauchant de l'hémiplégique, l'aspect soudé du parkinsonien

Le goitre, l'exophtalmie, l'agitation du basedowien; le faciès infiltré de l'hypothyroïdien
Le faciès lunaire et l'obésité tronculaire du syndrome de cushing.

Bien observer la position du malade:

Le cirrhotique est couché sur le dos

Le cardiaque est assis sur le lit, avec des oreillers, cyanosé et turgescence des jugulaires

L'artéritique est assis les jambes pendantes

le pleurétique est couché sur le coté malade, il a une toux sèche et brève.

2. **Palpation** : est l'utilisation du sens tactile, le toucher

Il s'agit d'une pression exercée avec:

- **la face palmaire de la main**: pour palper un choc apexien, rechercher un frémissement cardiaque, apprécier la transmission des vibrations vocales.
- **ou la pulpe des doigts**: pour palper une pulsation vasculaire
- **ou la face palmaire de la pulpe des doigts**: pour déterminer le contour et la taille d'un organe profond (rate, foie), de la glande thyroïde, les caractéristiques d'une tuméfaction, des adénopathies, d'une zone douloureuse.

3. **Percussion**: 2 techniques : percussion médiate et percussion immédiate.

Percussion immédiate ou directe: se fait par un coup sec à l'aide d'un doigt ou plusieurs doigts réunis de l'examineur sur la surface à examiner.

Percussion médiate: l'utilisation d'un doigt (doigt percuteur), en général le médius droit, pour **frapper brièvement**: "**percuter**" extrémité distal d'un doigt de l'autre main posé sur la surface du thorax ou de l'abdomen.

Résultat: la sensation tactile du son produit, telle qu'une **sonorité ou matité** (air, liquide) nous renseigne sur la structure des organes ou des tissus sous jacents.

- la percussion sur un organe solide: tel que le foie: produit un son mat
- la percussion dans une structure contenant l'air: tel que le poumon: produit une sonorité
- la percussion dans une structure creuse contenant l'air: tel que l'estomac: produit un son tympanique.

Ex : la percussion d'une matité sur la partie médiane basse de l'abdomen est probablement celle d'une vessie pleine.

4. **Auscultation**:

C'est l'écoute de son produit par les organes internes à l'aide d'un **stéthoscope**.

On ausculte le **cœur**, les **poumons et artères** (l'aorte abdominale, carotides, artères rénales).

- **le cœur**: on déplace le stéthoscope de proche en proche en partant de la pointe vers la base, on identifie **les bruits cardiaques normaux (B1, B2)** correspondant à la fermeture des valves, on recherche également les bruits surajoutés, les souffles, un frottement ou un assourdissement des bruits: dû à une péricardite.
- **les poumons**: l'auscultation se fait de manière comparative au niveau des 2 hémithorax de haut en bas, sur la face antérieure, postérieure et latérale, on demande au patient de respirer par la bouche (respiration lente et profonde), elle permet d'évaluer le passage de l'air dans l'arbre trachéo-bronchique.

On peut ausculter également l'abdomen: absence de bruits intestinaux normaux peut traduire une urgence chirurgicale.

III. Séquence de l'examen physique

L'examen est réalisé de façon méthodique et organisé de la tête aux pieds en expliquant au fur et à mesure les différentes manœuvres au patient.

On commence toujours par apprécier l'état général, les constantes vitales puis l'examen de la peau ensuite l'examen appareil par appareil.

L'état général:

Appréciation générale sur l'état de santé apparent: bon , moyen ou altéré

L'état de conscience

Evaluation des constantes hémodynamiques: FC, FR, TA T°C

L'état d'hydratation: signes de déshydratation

L'état nutritionnel: poids / taille et calcul du BMI

La coloration de la peau: anémie, ictère, mélanodermie

La température: syndrome infectieux

Recherche de lésions cutanées: nodules, érythème

D'un hippocratisme digital

D'un syndrome œdémateux : signe de godet

D'un syndrome hémorragique: purpura, ecchymoses

Examen De La Tête:

Examen de la peau: sa coloration, sa pigmentation, sa texture, son infiltration

Recherchez une asymétrie

L'Aspect des phanères: ex: cheveux fins et cassants, une alopécie, une chute de la queue de sourcils).

Examen des yeux:

- ✓ Examen des conjonctives: pâle, ictère
- ✓ Xanthélasmas: hyperlipémie
- ✓ Exophtalmie
- ✓ Ptosis, Strabisme

Examen de la cavité buccale:

Comprend: la muqueuse buccale, les lèvres, la langue, voile du palais, dents, glandes salivaires.

Examen de la langue:

- ✓ Humide et rosée à l'état normal
- ✓ Blanche et saburrale dans certaines infections
- ✓ Sèche, rôtie : déshydratations
- ✓ Lisse décapillée: Biermer: glossite de Hunter
- ✓ Rouge, luisante: cirrhose
- ✓ Macroglossie: hypothyroïdie, amylose

Examen des dents:

- ✓ Modifications morphologiques, chute précoce, caries.

Examen de la face interne des joues:

- ✓ Signe de Koplick de la rougeole
- ✓ Taches ardoisées en cas d'insuffisance surrénale
- ✓ tache blanchâtre: Leucoplasie ou lichen.

Examen du pharynx:

Amygdales : volume, couleur, exsudats, fausses membranes

Voile du palais.

Examen du cou

Nous renseigne sur :

- ✓ la glande thyroïde
- ✓ Présence d'adénopathies cervicales, masse cervicale
- ✓ gros vaisseaux: artères carotides et veines jugulaires.

Inspection:

Elargissement de la base du cou: goitre

Saillie latérale: Adénopathie

Battement exagéré des carotides, turgescence des jugulaires

Palpation: examen de la thyroïde et palpation des aires ganglionnaires

Auscultation: des artères carotides.

Examen du thorax

Le torse doit être nu, il inclut l'examen cardiaque avec le système vasculaire périphérique, l'examen respiratoire, l'examen des seins et le creux des aisselles.

L'inspection recherche : une asymétrie thoracique, les modifications du rachis: cyphose, scoliose, une circulation veineuse collatérale (CVC), un œdème en pèlerine évoquant un syndrome cave supérieur, des angiomes stellaires, une gynécomastie unilatérale: cancer du poumon, un comblement des creux sus claviculaires, d'une adénopathie (ganglion de Troisier).

L'examen de l'appareil cardio-vasculaire normal : note: le choc apexien est au niveau du 5ème EIC gauche, B1B2 audibles, pas de souffles, pas de galop, pas de frottement.

L'examen respiratoire normal note: un thorax symétrique, une bonne ampliation thoracique, poumons sonores, murmure vésiculaire audible, pas de râles ni sifflements.

Examen des seins (examen gynécologique).

Examen de l'abdomen

Patient en position de décubitus dorsal, relâché, la tête reposant sur le lit, les membres inférieurs demi-fléchies.

S'asseoir à droite du malade.

L'Inspection: apprécie le volume de l'abdomen, recherche une voussure, une dépression, une hernie ombilical, une CVC.

La palpation : est l'étape essentielle de l'examen

Elle apprécie : le tonus de la paroi abdominale: à l'état normal : la paroi est souple, la présence d'une défense ou contracture correspond à une irritation péritonéale.

Elle recherche: une hypertrophie d'un viscère, la présence d'une hernie, d'une tumeur, l'existence de points douloureux particuliers: point vésiculaire par la manœuvre de Murphy.

La percussion: En décubitus dorsal, elle doit être douce.

Chez le sujet normal: permet de délimiter le bord supérieur et inférieur de la matité hépatique pour le calcul de la flèche hépatique, par ailleurs l'abdomen est sonore.

Les anomalies: matité déclive évoquant une ascite.

L'auscultation: apporte peu de renseignements, peut mettre en évidence:

Un silence auscultatoire: au cours de l'occlusion intestinale

Un souffle: en cas compression vasculaire ou d'anévrisme de l'aorte abdominale.

Examen des fosses lombaires:

A la recherche d'un gros rein, de points douloureux urétéraux, un globe vésical.

Examen des régions inguino-crurales:

Hernies inguinales, Hernies crurales, Adénopathies

Examen de la région anale:

Examen de la région anale

Inspection :

- ✓ Maladies hémorroïdaires, fissure, fistule, condylomes

Toucher rectal: doigtier et lubrifiant

- ✓ Dououreux ou non
- ✓ Hémorroïdes internes
- ✓ Etat de la prostate
- ✓ Recherche de tumeur rectale
- ✓ Sphincter anal
- ✓ Couleur des selles: rectorragies, méléna

Examen: ostéo-articulaire

L'examen des membres supérieurs et inférieurs, du rachis cervical, dorsal, lombaire et du pelvis.

La recherche: des signes inflammatoires articulaires, une raideur articulaire, les déformations osseuses, articulaires; on apprécie la mobilité articulaire.

Examen neurologique:

Etat de conscience

L'orientation temporo-spatiale

Station debout, la marche et l'équilibre

Les paires crâniennes

Etude de la sensibilité superficielle et profonde

Etude de la motricité, tonus musculaire, reflexes ostéo-tendineux.

Bibliographie:

1. Sémiologie Médicale. Examen clinique, Pr Malek Rachid CHU Sétif
2. Manuel de diagnostic clinique : historique et examen physique, Mark H .Swartz
3. Guide de l'examen clinique, Barbara Bates
4. Practical Guide to Clinical Medicine Charlie Goldberg, MD, UCSD School of Medicine et VA Medical Center, San Diego Californie 92093-0611.